

× 抗緑膿菌活性を有する抗菌薬を速やかに開始する。数日の抗菌薬加療でも発熱が遷延する場合は、真菌感染の可能性を評価する。

× 細胞性免疫不全では抗酸菌、ヘルペスウイルス、ノカルジア、真菌による感染症のリスクが増加する。莢膜を有する菌のリスクが上がるのは液性免疫不全である。

1

○

○

ノカルジアは抗酸菌染色で染色されるが、アクチノマイセスでは染色されないため、識別の手がかりとなる。

○

×

脳膿瘍の合併が多いのはノカルジアである。

○

菌名によって感受性が異なりST合剤が使用できないケースもあるため注意する。なお、アクチノマイセスはペニシリン系抗菌薬を第一選択とする。

×

免疫不全の程度や重症度によるが、概ね6~12ヶ月程度の長期間の治療を必要とする。